

Material de supervisión

Sesión N° 1, [fecha xx/xx/xxxx]

La sesión tiene una energía sostenida y orientada hacia la acción desde el comienzo: la paciente llega desbordada y el terapeuta construye rápidamente una estructura que contiene el caos cognitivo y culmina en un compromiso conductual concreto. El trabajo es activo, coherente con un marco contextual-conductual, y deja a la paciente en un lugar visiblemente más esperanzado. Queda para supervisión explorar qué estuvo presente —y qué ausente— en el vínculo durante ese proceso.

Momento 1 — La irrupción inicial y la respuesta al "tienes que estar en mi lugar"

La paciente entra hablando a gran velocidad, acumulando razones por las que no puede avanzar: la edad, los años fuera del mercado, los hijos, la obsolescencia. Hay una figura clara que emerge: no soy suficiente, que ella misma nombra cuando se le propone el ejercicio del "capitán". Junto con esa figura aparece una forma de confluencia invertida: "si no estás en mi lugar no puedes entender", que funciona como interrupción del contacto —un movimiento que simultáneamente pide ser vista y descarta de antemano la posibilidad de serlo.

¿Qué resonó en el terapeuta en ese momento? La respuesta ante ese desafío ("tienes que estar en mi lugar") fue ágil y técnicamente hábil —la metáfora del equipo—, pero vale preguntarse si hubo algo de esa frase que tocó al terapeuta antes de ser encuadrada. ¿Hubo un momento de incomodidad, de querer demostrar comprensión, de acelerar hacia la intervención para no quedarse en ese lugar de "el que no entiende"? Esa dinámica no quedó nombrada en la sesión.

Preguntas para supervisión:

- ¿Qué le produjo al terapeuta ese "solo estando en mi lugar podrías entender"? ¿Hubo algo propio activado —necesidad de validar la propia comprensión, urgencia por demostrar eficacia — que pueda haber acelerado el movimiento hacia la técnica?
- ¿Qué habría pasado si antes de estructurar los pensamientos en "equipo", el terapeuta se hubiera detenido un momento más en ese pedido de ser vista?

Momento 2 — El experimento de defusión y la pregunta por la presencia corporal del terapeuta

El ejercicio de escribir los pensamientos y observarlos —contar palabras, notar mayúsculas, identificar color de tinta— fue el núcleo técnico de la sesión y produjo un efecto visible: la paciente comenzó a distinguirse de sus pensamientos, a verlos como objetos observables. El trabajo fue claro y bien sostenido.

Sin embargo, desde una lectura gestáltica, el foco estuvo casi enteramente en el contenido cognitivo y en el comportamiento observable futuro (hacer el currículum). El cuerpo de la paciente —que ella misma mencionó: "siento como que se me sube un calor"— apareció brevemente y no fue retomado. Ese calor que sube podría haber sido una puerta de entrada al contacto sensorial con la angustia, no solo a su observación desde afuera.

¿Cómo estaba el terapeuta corporalmente durante ese ejercicio? ¿Hubo en él también algo de aceleración, de satisfacción ante la técnica que funciona, que pudo haber llevado la sesión hacia lo cognitivo y alejado del contacto con la experiencia somática de la paciente?

Preguntas para supervisión:
- ¿Qué habría pasado si el terapeuta hubiera invitado a la paciente a quedarse un momento con ese calor que sube, antes de pasar a observar el pensamiento como objeto?
- ¿Qué polaridad propia podría estar operando en el terapeuta entre sostener la angustia y ofrecer una salida eficaz?

Momento 3 — La proyección hacia el futuro y el cierre esperanzador

El tramo final —imaginar qué pasaría después de una semana, de un mes, qué sentiría con sus hijos, con su marido— generó un cambio emocional genuino y la paciente se conectó con algo valioso: el deseo de volver a sentirse activa, presente, sin rencor. Es un cierre que la deja motivada.

Al mismo tiempo, la sesión termina con una imagen casi sin sombra: el currículum se hace, los pensamientos se observan, el rencor desaparece de la atención. La paciente misma pone un freno espontáneo —"igual no me lo creo tanto"— que fue recogido brevemente pero no profundizado. Esa duda podría ser el borde más vivo de la sesión: el lugar donde la esperanza y el miedo al fracaso coexisten, y donde el contacto real podría haberse profundizado.

Preguntas para supervisión:
- ¿Qué hizo el terapeuta con ese "igual no me lo creo tanto"? ¿Fue un ajuste creativo de la paciente que merecía más espacio, o era funcionalmente útil sostener el impulso hacia adelante en esta primera sesión?
- ¿Hay algo en el cierre esperanzador que responda también a una necesidad del terapeuta —de terminar bien, de que la intervención haya servido— que valga la pena revisar?